

Constipation

Information pour le patient · Pourquoi c'est important pour la santé pelvienne, et comment y remédier

WARWIKI

La constipation se caractérise par des selles **peu fréquentes, dures ou difficiles à évacuer**. C'est un problème très courant — et il importe pour la santé pelvienne, car les **efforts de poussée** qu'il provoque aggravent le prolapsus, les fuites urinaires et les douleurs pelviennes. La bonne nouvelle : la plupart des constipations s'améliorent grâce à des changements simples et éprouvés.

À propos de cette affection

Des selles normales doivent s'évacuer sans effort. Les signes de constipation comprennent : moins de trois selles par semaine, selles dures ou grumeleuses, efforts de poussée, sensation de **vidange incomplète**, ou besoin d'appuyer près du vagin ou du rectum pour faciliter l'évacuation (« splinting »).

Causes

- **Peu de fibres et de liquides**, et manque d'activité physique
- **Ignorer l'envie** d'aller à la selle
- **Médicaments** — opioïdes, fer, et certains autres
- **Problèmes du plancher pelvien** — les muscles ne se relâchent pas pour laisser passer les selles (constipation « terminale »)
- Ralentissement du transit colique

La constipation « terminale » est importante : elle se traite par la **rééducation du plancher pelvien**, et pas seulement par des laxatifs.

COMPRENDRE LES TERMES

Constipation

Selles peu fréquentes, dures ou difficiles à évacuer.

Fibres

Matières végétales qui ramollissent et donnent du volume aux selles.

Laxatif osmotique

Agent doux (comme le PEG) qui attire l'eau dans les selles.

Constipation terminale

Difficulté à évacuer les selles car les muscles pelviens ne se relâchent pas.

Biofeedback

Thérapie qui réapprend aux muscles à se relâcher lors d'une selle.

Splinting

Appuyer près du vagin ou du rectum pour aider les selles à passer.

POURQUOI MON UROLOGUE S'Y INTÉRESSE-T-IL ? Parce que les efforts pour évacuer des selles dures exercent une pression sur les mêmes structures qui soutiennent la vessie et les organes pelviens — la constipation aggrave ainsi le prolapsus et l'incontinence urinaire, et un rectum plein peut comprimer la vessie. Traiter la constipation améliore souvent aussi les symptômes urinaires.

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Fibres, liquides et activité** — augmentez les fibres progressivement (alimentation ou complément) avec beaucoup d'eau.
- 2 **Habitudes aux toilettes** — allez dès que vous en ressentez le besoin, utilisez un **repose-pieds** pour relever les genoux (position accroupie), et **n'exercez pas de poussée**.
- 3 **Laxatifs doux** — un agent osmotique (comme le PEG) peut être utilisé régulièrement si nécessaire.
- 4 **Rééducation du plancher pelvien / biofeedback** en cas de constipation terminale ; passez en revue avec votre équipe les médicaments pouvant causer la constipation.

Une routine saine

- Essayez d'aller à la selle à la **même heure chaque jour**, souvent après un repas.
- Accordez-vous du temps, sans précipitation ; ne forcez jamais.
- Restez actif(ve) — même une marche quotidienne favorise le transit.

Bon à savoir

- Augmentez les fibres **lentement** pour éviter les ballonnements, et buvez suffisamment d'eau.
- Les laxatifs stimulants sont acceptables à l'occasion ; consultez votre équipe avant un usage quotidien.
- Si la poussée est le principal problème, il peut s'agir d'un manque de coordination musculaire — la rééducation est plus efficace que davantage de laxatifs.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Du sang dans les selles** ou une perte de poids inexpliquée
- Une constipation récente qui ne s'améliore pas, surtout si vous êtes âgé(e)
- Des douleurs abdominales intenses, des vomissements ou **absence totale de gaz ou de selles** (possible occlusion)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La constipation est fréquente et importante pour la santé pelvienne — les efforts de poussée aggravent le prolapsus et les fuites urinaires.
2. Traitez-la avec des fibres, des liquides, de l'activité, de bonnes habitudes aux toilettes (repose-pieds, sans pousser) et des laxatifs doux si nécessaire.
3. Si les efforts persistent, demandez une rééducation du plancher pelvien. Signalez tout sang dans les selles, toute perte de poids ou changement soudain et sévère.